

评价双特异性抗体 **MR001** 在晚期实体瘤患者中的
安全性、耐受性的临床研究
研究数据审阅者指南

申办者	深圳市迈加瑞生物技术有限公司
方案编号	MJR-MR001-01
方案版本号	V3.0
版本号	1.0
版本日期	06/27/2025

目录

1. 介绍 1

1.1. 目的 1

1.2. 缩略语 1

1.3. 研究数据标准和字典版本 1

2. 方案描述 2

2.1. 方案编号和标题 2

2.2. 方案设计 2

2.3. 试验设计数据集 5

2.3.1 TA – 试验分组 5

2.3.2 TE – 试验元素 5

2.3.3 TV – 试验访视 5

2.3.4 TI – 试验入选/排除标准 5

2.3.5 TS – 试验概要 5

3. 受试者数据描述 6

3.1 概述 6

3.2 溯源流程图 6

3.3 注释病例报告表 6

3.4 SDTM 受试者域 6

3.4.1 AE – 不良事件 8

3.4.2 CM – 既往与合并用药 8

3.4.3 DM – 人口学 9

3.4.4 DS – 处置 10

3.4.5 DV – 方案偏离 10

3.4.6 EC – 暴露采集 11

3.4.7 EG – 心电图 11

3.4.8 EX – 暴露 11

3.4.9 IS – 免疫原性检验 12

3.4.10 IE – 不满足的入选/排除标准 12

3.4.11 LB – 实验室检查 12

3.4.12 MH – 既往病史 12

3.4.13 PC – 药代动力学浓度 13

3.4.14 PE – 体格检查 13

3.4.15 PP – 药代动力学参数 13

3.4.16 PR – 诊疗操作 14

3.4.17 QS – 问卷与量表 14

3.4.18 RS – 疾病效应/状态评估 14

3.4.19	SE – 受试者元素	15
3.4.20	SS – 受试者状态.....	15
3.4.21	SV – 受试者访视.....	15
3.4.22	TR – 肿瘤/病灶测量	15
3.4.23	TU – 肿瘤/病灶标识.....	15
3.4.24	VS – 生命体征	16
4.	数据一致性总结	16
4.1	一致性的输入.....	16
4.2	问题总结.....	16
4.3	补充的一致性明细	19
附录 I:	入选/排除标准	20

1. 介绍

1.1. 目的

本文档提供列表数据集和术语相关内容，这些内容属于数据定义文档（define.xml）额外的解释。此外，本文档还提供了 SDTM 一致性发现的结果。

1.2. 缩略语

缩略语	英文全称	翻译
aCRF	Annotated Case Report Form	注释病例报告表

1.3. 研究数据标准和字典版本

标准或字典	使用的版本
SDTM	SDTM IG v3.2
Controlled Terminology	SDTM Terminology_20240927
Data Definitions	define.xml v2.1
Medications Dictionary	WHODRUG_GLOBALB3Sep22
Medical Events Dictionary	MedDRA v27.1

2. 方案描述

2.1. 方案编号和标题

方案编号：MJR-MR001-01

方案标题：评价双特异性抗体 MR001 在晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性的临床研究

2.2. 方案设计

本研究采用单臂、开放性、剂量递增设计，在晚期实体瘤患者中进行首次人体研究，预计纳入 17~32 例患者，评价双特异性抗体 MR001 的安全性和耐受性，初步有效性、药代动力学特征，探索药效动力学特征。本研究包括筛选/基线期（28 天）、治疗期（每 21 天为 1 个周期）、和随访期（90 天）。采用加速滴定和“3+3”剂量递增设计，本研究共 7 个剂量组，分别为 0.1mg/kg、0.5mg/kg、2mg/kg、6mg/kg、10mg/kg、15mg/kg、20mg/kg（在临床试验中，将根据实际人体 PK、疗效数据，以及安全性、耐受性情况，酌情调整爬坡剂量），第一、二剂量组采用加速滴定，每个剂量组入组至少 1 例患者，完成 DLT 观察期后，初步确定安全耐受后，可进入下一剂量组；后续剂量组采用“3+3”剂量递增设计，每个剂量组最后 1 例患者完成给药后的 DLT 评估之后，由研究者和申办方结合临床安全性和药代动力学数据评估同意进入下一剂量组后，可开始下一个剂量组的治疗。每例受试者只能参加 1 个剂量组的研究。

第一、二剂量组进行 1 个周期给药，完成 DLT 安全观察期后则退出试验。其他剂量组的研究治疗周期将持续进行，直至疾病进展、撤回知情同意书或研究者判定受试者不再获益，治疗周期最长不超过 4 周期。

试验流程见下图。

项目	筛选/基线期	治疗期（每 21 天为 1 个周期）																	随访期		
		第一周期（C1）					第二周期（C2）					第三周期（C3）				第四周期（C4）			治疗结束/ 提前退出 访视	安全性 访视	生存访视 ¹⁷
时间	D-28 到 D-1	D1	D5 ±1	D8 ±1	D15 ±3	D21 ±3	D1 ±3	D5±1	D8±1	D15±3	D21 ±3	D1 ±3	D5±1	D8±1	D15±3	D1±7	D5±1	D15±3	末次用药 后 30±7 天	末次用 药后 60±7 天	末次用药 后，每 90 天 (±14 天)
签署知情	X																				
核查入选/ 排除标准	X																				
人口学/既往 病史/ 既往治疗	X																				
身高/体重	X	X					X					X				X					
体格检查	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
生命体征	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
ECOG 评分	X	X					X					X				X			X		
合并用药		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
妊娠检查	X	X					X					X				X			X		
输血四项	X																				
影像学检查/ 肿瘤评估	X										X								X		
12 导联心 电图	X	X		X		X	X					X				X			X		

项目	筛选/ 基线期	治疗期（每 21 天为 1 个周期）																	随访期		
		第一周期（C1）					第二周期（C2）					第三周期（C3）				第四周期（C4）			治疗结束/ 提前退出 访视	安全性 访视	生存访视 ¹⁷
时间	D-28 到 D-1	D1	D5 ±1	D8 ±1	D15 ±3	D21 ±3	D1 ±3	D5±1	D8±1	D15±3	D21 ±3	D1 ±3	D5±1	D8±1	D15±3	D1±7	D5±1	D15±3	末次用药 后 30±7 天	末次用 药后 60±7 天	末次用药 后，每 90 天 (±14 天)
实验室检查 (血常规、 血生化等)	X	X	X		X		X	X				X	X			X	X		X		
甲状腺功能	X																		X		
T 细胞亚群	X											X				X			X		
心脏超声	X						X					X				X			X		
给药		X					X					X				X					
不良事件		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PK 采血		X					X					X				X					X
ADA 采血		X		X	X					X					X			X			
药效学指标 采集		X					X		X			X			X	X					X
生存信息																					X

2.3. 试验设计数据集

提交的材料中包括试验设计数据集吗？
是

数据集	数据集标签
TA	试验分组
TE	试验元素
TV	试验访视
TI	试验入选/排除标准
TS	试验概要

2.3.1 TA – 试验分组

本研究的主要目的是评估双特异性抗体 MR001 在晚期实体瘤患者中的安全性和耐受性。确定双特异性抗体 MR001 的剂量限制性毒性（DLT）和最大耐受剂量（MTD）。次要目的是评估双特异性抗体 MR001 在晚期实体瘤患者者中的药代动力学特征，获取初步药代动力学参数；评估双特异性抗体 MR001 在晚期实体瘤患者中的初步疗效，为后续临床试验推荐剂量提供依据；评价双特异性抗体 MR001 在晚期实体瘤患者中的免疫原性。探索性目的是探索双特异性抗体 MR001 在晚期实体瘤患者中的药效学指标的特征。

ARM 分别为 MR001(0.1mg/kg)、MR001(0.5mg/kg)、MR001(2mg/kg)、MR001(6mg/kg)、MR001(10mg/kg)。

2.3.2 TE – 试验元素

本试验包含三种元素：筛选期、治疗期、随访期。

2.3.3 TV – 试验访视

方案中未明确规定计划外随访的相关日期，但 EDC 收集到“计划外检查”因此将其列入计划内随访列表。

2.3.4 TI – 试验入选/排除标准

TI 数据集中的试验入选/排除标准由于方案中完整的入选/排除标准描述超过了 200 个字符，因此进行了简化。完整的入选/排除标准见附录 I:入选/排除标准。

2.3.5 TS – 试验概要

本试验的最后一次访视日期被用于定义参数 SENDTC（Study End Date）。

3. 受试者数据描述

3.1 概述

提交的数据是否来自一项正在进行的研究？
是。

SDTM 数据集是否用作分析数据集的来源？
是。

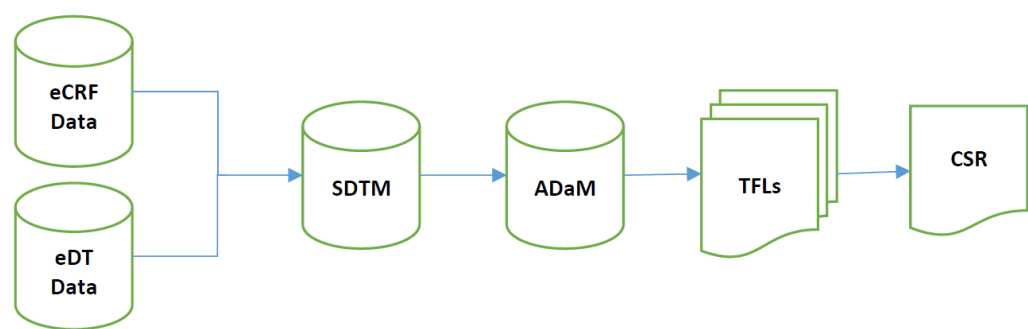
提交的数据集包括筛选失败的受试者吗？
是，提交的数据集中 DM、SUPPDM、DS、SUPPDS、IE、SUPPIE、SE、SV、SUPPSV 中包括筛选失败的受试者。

是否因为没有数据收集导致存在域是计划提交却没有提交？
否。

提交的数据是收集数据的子集吗？
否，提交的数据与收集的数据范围一致。

是否有判决数据存在？
否。

3.2 溯源流程图



3.3 注释病例报告表

在注释病历报告表中，注释标注了 SDTM 中提交的数据。只有通过病例报告表收集的数据才会被标注。收集的字段里为指定值的，放在虚线长方形框中。收集的字段里不需要被 SDTM 列表模型收集的，被标注为放在实线长方形框中的“不递交”。

3.4 SDTM 受试者域

数据集 – 数据集 标签	疗效性	安全性	其他	自定义域	SUPP-	使用 RELREC 相关的域	观察类别
<u>AE–不良事件</u>		X			X		事件类

数据集 - 数据集 标签	疗效性	安全性	其他	自定义域	SUPP-	使用 RELREC 相关的域	观察类别
<u>CM-既往与合并用药</u>			X		X		干预类
<u>DM-人口学</u>			X		X		人口学
<u>DS-处置</u>			X		X		事件类
<u>DV-方案偏离</u>			X		X		事件类
<u>EC-暴露采集</u>			X		X		干预类
<u>EG-心电图</u>		X			X		发现类
<u>EX-暴露</u>			X		X		干预类
<u>IS-免疫原性检验</u>	X				X		发现类
<u>IE-不满足的入选/ 排除标准</u>			X		X		发现类
<u>LB-实验室检查</u>		X			X		发现类
<u>MH-既往病史</u>		X			X		事件类
<u>PC-药代动力学浓度</u>	X				X		发现类
<u>PE-体格检查</u>		X			X		发现类
<u>PP-药代动力学参数</u>	X				X		发现类
<u>PR-诊疗操作</u>			X		X		干预类
<u>QS-问卷与量表</u>	X						发现类
<u>RS-疾病效应/状态 评估</u>	X				X		发现类
<u>SE-受试者元素</u>			X				特殊用途
<u>SS-受试者状态</u>	X				X		发现类
<u>SV-受试者访视</u>			X		X		特殊用途
<u>TR-肿瘤/病灶测量</u>	X				X		发现类

数据集 – 数据集 标签	疗效性	安全性	其他	自定义域	SUPP-	使用 RELREC 相关的域	观察类别
<u>TU-肿瘤/病灶标识</u>	X				X		发现类
<u>VS-生命体征</u>		X			X		发现类

3.4.1 AE – 不良事件

不良事件域（AE）记录的是从签署知情同意书开始直至安全随访期结束的不良事件。AEs 将使用监管活动医学词典（MedDRA 27.1）进行编码。编码的相关变量如下：AELLT, AELLTCD, AEDECOD, AEPTCD, AEHLT, AEHLTCD, AEHLGT, AEHLGTCD, AEBODSYS, AEBDSYCD, AESOC 和 AESOCCD。

如果不良事件是严重不良事件，则 AESER = “Y”，六个严重标准变量 AESCONG, AESDISAB, AESDTH, AESHOSP, AESLIFE 或 AESMIE 中至少一个变量值 = “Y”。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
AEACT	对 AE 采取的措施
AECMNO	采取的用药编号 CMSEQ
AEPRNO	采取的干预编号 PRSEQ
AEACTOTH	对 AE 采取的其他措施
AEDIS	是否为导致停药的不良事件
DICNAME	词典名称
DICVER	词典版本
AETRTEM	是否为治疗中出现的不良事件
AEYN	是否为不良事件
AEIMP	是否为重要不良事件
AEIRYN	是否为免疫相关不良事件

3.4.2 CM – 既往与合并用药

既往与合并用药域（CM）收集了受试者用药史、既往肿瘤化疗史、既往其他肿瘤治疗史、合并用药/新的抗肿瘤用药。将用药结束日期早于首次给药日期的用药定义为既往用药，将用药起始日期大于或等于首次给药日期，但不晚于末次使用 MR001 后 30 天的用药定义为合并用药。起始于首次给药日期之前，并且结束于首次给药日期之后或持续的用药也被定义为合并用药。既往和合并用药采用 WHODRUG_GLOBALB3Sep22 进行编码，

WHODRUG_GLOBALB3Sep22 编码信息也收集到 SUPPCM, 其他在 CRF 收集或派生的信息映射到 SUPPCM 如下:

QNAM	描述
CMSPID	自定义标识符
CMINDCO	其他适应症
CMAENO	相关 AE 编号
CMMHNO	相关 MH 编号
CMPG	化疗方案
CMBO	最佳治疗效果
CMDOSUO	其他剂量单位
CMDOSFRO	其他频率
CMROUOTH	其他给药途径
CMONGO	是否仍持续
CTHTP	化疗类型
CTHTPOTH	其他化疗类型
CMLOC	放射治疗部位
ATC1	ATC1 级术语
ATC1CD	ATC1 级术语代码
ATC2	ATC2 级术语
ATC2CD	ATC2 级术语代码
ATC3	ATC3 级术语
ATC3CD	ATC3 级术语代码
ATC4	ATC4 级术语
ATC4CD	ATC4 级术语代码
PTNAME	首选语
PTNAME1	首选语 1
PTCODE	首选语代码
DICVER	词典版本

3.4.3 DM – 人口学

人口学域 (DM) 收集受试者相关的人口学信息, 每个受试者只有一条记录。该域的补充修饰变量名称如下:

QNAM	描述
TESTNUMC	受试者编号
TESTNUM	受试者编号(数值)
DTHREA	死亡原因

QNAM	描述
CHBEYN	是否为育龄妇女
ETHNICOT	其他族群
ARMNRS	计划或实际分组为空的原因
ACTARMUD	计划外分组描述
STATUS	筛选成功失败情况
STATUSE	入组未入组情况
SCRREA	筛选失败原因
SCRSPEC	未入组原因
RANDDT	入组日期
DLTYN	是否发生 DLT 事件
DLTDTC	DLT 事件发生日期
DLTTYPE	DLT 类别
DSYN	是否完成研究
DSDTC	完成研究日期
DSDECOD	未完成研究的原因
DSOTH	未完成研究的原因详述

3.4.4 DS – 处置

处置域 (DS) 提供参加研究的所有受试者的概况，包括试验方案的里程碑事件。本试验用变量 DSCAT 区分两类事件。其一为“方案里程碑”，其二为“处置事件”，具体值记录在变量 DSDECOD 及 DSTERM 里。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
DSOTH	其他关于事件的描述

3.4.5 DV – 方案偏离

方案偏离域 (DV) 记录了研究过程中的方案违背和偏离。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
DVTERM1	方案偏离报告名称 1
DVTERM2	方案偏离报告名称 2
DVTERM3	方案偏离报告名称 3
DVTERM4	方案偏离报告名称 4
DVSEV	PD 分级(严重程度)
DVEFF	PD 处理情况
DVEFF1	PD 处理情况 1
DVEFF2	PD 处理情况 2

QNAM	描述
DVVISIT	PD 发生访视
DVREDTC	记录日期
DVSPEC	备注
SITID	研究中心编号
SITNAME	研究中心名称

3.4.6 EC – 暴露采集

暴露采集域（EC）模型反映了收集的方案定义的研究治疗给药。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
VISIT	访视名称
VISITNUM	访视编号
ECPDOSE	计划给药量
ECPDOSU	计划给药量单位

3.4.7 EG – 心电图

心电图域（EG）记录 12-导联心电图的结果。临床意义和异常描述信息的详细描述记录在 SUPPEG 中。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
EGLOBXFL	定义的基线标识
EGSPEC	临床情况详述
EGSPEC1	临床情况详述 1

3.4.8 EX – 暴露

暴露域（EX）收集了受试者暴露于方案定义的研究治疗的细节。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
VISIT	访视名称
VISITNUM	访视编号
EXPDOSE	计划给药量
EXPDOSU	计划给药量单位
EXIRYN	是否发生输液反应
EXIRRE	发生输液反应后处理措施

3.4.9 IS – 免疫原性检验

免疫原性检验域（IS）收集了第 1、2 剂量组（0.1 mg/kg、0.5 mg/kg）受试者于给药前，给药开始后 168 和 336 h，采集 4 ml 全血，用于检测抗 MR001 抗体。第 3 至最高剂量组受试者于第 1 周期给药前，给药开始后 168 和 336 h；第 2、3、4 次给药后 336h，采集 4 mL 全血，用于检测抗 MR001 抗体。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
ISTPT	计划时点名称
ISTPTNUM	计划时点编号
ISTPTREF	参照时点
ISRFTDTC	参照时点日期/时间
ISTPTD	计划采血点
ISTPTN	计划采血点数值型
ISDESC	备注

3.4.10 IE – 不满足的入选/排除标准

不满足的入选/排除标准域（IE）收集了导致受试者违反入选/排除标准的标准。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
RFICDTC	知情同意书签署日期

3.4.11 LB – 实验室检查

实验室检查域（LB）收集了实验室检查的数据，比如血常规，尿常规，血生化，凝血功能等。具体 LBTEST 参照 define.xml。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
LBLOBXFL	定义的基线标识
LBCLSIG	临床意义
LBCLSIGS	临床情况详述
LBCATN	类别编号
LBTESTN	检测项编号
LBLVEF	射血分数

3.4.12 MH – 既往病史

既往病史域（MH）收集受试者既往/现病史、既往肿瘤史。采用医学注册术语词典（MedDRA）27.1 或以上版本对既往病史/肿瘤史进行编码。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
MHSPID	自定义标识符
MHTERM1	病史报告名称 1
MHSTDY	开始日
MHONGO	是否仍持续
MHTTYN	肿瘤治疗是/否
DICNAME	词典名称
DICVER	词典版本

3.4.13 PC – 药代动力学浓度

药代动力学浓度域（PC）收集了受试者药代动力学（PK）和药效学（PD）的血样采集及检测结果信息。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
PCTPTD	计划采血点
PCTPTN	计划采血点数值型
PCDESC	备注

3.4.14 PE – 体格检查

体格检查域（PE）收集了体检的结果及对结果的描述。原始的检查结果被记录在 PEORRES 变量里，其他具体描述记录在 SUPPPE 中。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
PETESTN	检查项序号
PECATN	类别序号
PELOBXFL	基线标识
PEBLFL	定义的基线标识
PECOM	其他情况详细说明

3.4.15 PP – 药代动力学参数

药代动力学参数域（PP）收集了由药代动力学浓度-时间数据衍生的参数。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
PPTSTR	参数名称的 RTF 代码
PPTSTN	参数编号
PPCATN	类别编号

3.4.16 PR – 诊疗操作

诊疗操作域（PR）收集了受试者肿瘤诊断、手术史、合并治疗/新的抗肿瘤治疗相关信息。采用医学注册术语词典（MedDRA）27.1 或以上版本进行编码。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
PRSPID	自定义标识符
PRINDCO	治疗原因详述
PRLLT	低位语
PRLLTCD	低位语编码
PRDECOD	标准化名称
PRPTCD	首选语编码
PRHLT	高位语
PRHLTCD	高位语编码
PRHLGT	高位组语
PRHLGTCD	高位组语编码
PRBODSYS	系统器官分类
PRBDSYCD	系统器官分类编码
PRSOC	主系统器官分类
PRSOCOD	主系统器官分类编码
DICNAME	词典名称
DICVER	词典版本
PRONGO	是否仍持续
PROLS	肿瘤分期
PROMET	是否转移
PROLOC	转移部位

3.4.17 QS – 问卷与量表

问卷与量表域（QS）收集了受试者 ECOG 评分。该域不涉及补充修饰变量。

3.4.18 RS – 疾病效应/状态评估

疾病效应/状态评估域（RS）受试者肿瘤评估数据。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
RSLOBXFL	定义的基线标识
RSBLFL	基线标识

3.4.19 SE – 受试者元素

受试者元素域（SE）受试者元素的实际顺序，以及每个元素的开始日期/时间和结束日期/时间。该域不涉及补充修饰变量。

3.4.20 SS – 受试者状态

受试者状态域（SS）收集了受试者生存随访数据。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
SSWAY	随访方式
SSSFS	被随访人员
DTHDTC	最终确定存活日期

3.4.21 SV – 受试者访视

受试者访视域（SV）记录了受试者自参与试验后所有的访视信息，这些访视信息分散在其他各个包含访视变量的域中。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
SVPRESP	是否预先指定
SVOCCUR	事件是否发生

3.4.22 TR – 肿瘤/病灶测量

肿瘤/病灶测量域（TR）收集了肿瘤/病灶测量观测数据。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
ORGAN	器官
PART	部位
TRT01A	治疗组别
TRLOBXFL	定义的基线标识

3.4.23 TU – 肿瘤/病灶标识

肿瘤/病灶标识域（TU）收集了肿瘤/病灶检测方法及其器官部位。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
TUPART	详细部位
TULOBXFL	定义的基线标识

3.4.24 VS – 生命体征

生命体征域（VS）收集了生命体征观测数据，作为安全性指标的测量的一部分。本研究收集的信息包含：身高、体重、BMI、体温、脉搏、收缩压、舒张压、呼吸频率。该域的补充修饰变量名称如下：

QNAM	描述
VSTESTN	检查项编号
VSCATN	类别编号
VSLOBXFL	定义的基线标识
VSSTNRC	标准化正常值范围(文本结果)
VSCLSIG	临床意义
VSNRIND	相对参考范围指示符
VSSPEC	临床情况详述

4. 数据一致性总结

4.1 一致性的输入

域是否符合 CDISC SDTM 验证规则？

是，CDISC 版本和 SDTM 验证规则：SDTM IG v3.2 和 Pinnacle21-community-v4.1.0，配置为 SDTM-IG 3.2（NMPA）

是否使用申办方定义的验证规则来评估一致性？

否

SDTM 数据集是否与 define.xml 相关？

是

Define.xml 是否经过评估？

是

4.2 问题总结

数据集	诊断信息	类别	数量	解释
AE	结束时间点缺失	Consistency	46	转归为“未好转”、“不详”故 AE 结束时间缺失。
AE	AEOUT='死亡'时 AESDTH 不是 '是'	Consistency	1	01-S004-002 受试者因此条危及生命的 SAE 退出试验，随访追溯到死亡，故转归是死亡，但符合 SAE 标准只是危及生命
AE	SUPPAE 域内缺失 AESMIE 不良	Presence	1	SAE 报告中描述“综合评估考虑受试者目前营养不良加重至 3 级

数据集	诊断信息	类别	数量	解释
	事件详细信息			(卧床、无自理能力), 试验药物相关性判定同前, 受试者方拒绝就医诊治、尚未开始治疗。如营养不良状态持续未纠正, 继续加重可能导致严重后果, 属于“重要医学事件, 2024.6.14 进行 SAE 首次报告。”
AE	填有结束日期时 AEOUT = '未好转',	Consistency	6	受试者未痊愈
CM	Define.xml 中关键变量存在重复记录	Consistency	7	受试者严格按照'必要时使用'的原则用药。因原始记录中未采集具体给药时间, 故同一日期可能出现多条用药记录。
CM	结束时间点缺失	Consistency	29	还在持续使用药物
DS	同一 EPOCH 下有多个处置事件	Consistency	18	在本试验中首次给药完成情况、末次给药完成情况、试验完成情况是我们关注的重点事件。
DV	DVSTDTC 日期在 RFPENDTC 之后	Limit	1	PD 内容为样品保存超温, 发生日期可以在受试者的 RFPENDTC 之后
IS	有 ISORRES 值时 ISORRESU 值缺失	Consistency	2	免疫原性检查结果无单位
IS	有 ISSTRESC 值时 ISSTRESU 值缺失	Consistency	2	免疫原性检查结果无单位
IS	预期变量缺失所有记录的值	Presence	3	免疫原性检查无定量下限和单位
LB	基线记录缺少 LBSTRESC 值	Presence	17	基线期未做该指标的检查
LB	有 LBORRES 值时 LBORRESU 值缺失	Consistency	122	定性结果无单位
LB	有 LBSTRESC 值	Consistency	122	定性结果无单位

数据集	诊断信息	类别	数量	解释
	时 LBSTRESU 值 缺失			
LB	填有 LBORNRL0 时， LBORRES 的值 不是数值。	Consistency	54	检查结果为定性结果
LB	填有 LBORNRI 时，LBORRES 的值不是数值。	Consistency	54	检查结果为定性结果
LB	填有 LBSTNRLO 时，LBORRES 的值不是数值。	Consistency	49	1.检查结果为定性结果。 2.多中心指标标准化后部分指标 变更为定性结果。
LB	填有 LBSTNRHI 时，LBORRES 的值不是数值。	Consistency	49	1.检查结果为定性结果。 2.多中心指标标准化后部分指标 变更为定性结果。
MH	MHSTDTC 日期 在 RFSTDTC 之 后	Limit	2	这是一条间歇性的既往病史
MH	结束时间点缺失	Consistency	106	疾病仍持续
MH	开始时间点缺失	Consistency	6	受试者遗忘开始时间，故缺失
PC	有 PCORRES 值 时 PCORRESU 值 缺失	Consistency	61	比值指标无单位
PC	有 PCSTRESC 值 时 PCSTRESU 值 缺失	Consistency	61	比值指标无单位
PC	所有记录中都缺 失相关允许变量	Presence	2	均存在结果无需 PCSTAT、 PCREASND 进行修饰
PP	有 PPRFTDTC 值 时 PPTPTREF 值 缺失	Presence	1	相对于 C1D1 或 C4D1 给药
PP	有 PPORRES 值 时 PPORRESU 值 缺失	Consistency	5	比值指标无单位

数据集	诊断信息	类别	数量	解释
PP	有 PPSTRESC 值 时 PPSTRESU 值 缺失	Consistency	5	比值指标无单位
PP	所有记录中都缺 失相关允许变量	Presence	2	均存在结果无需 PPSTAT、 PPREASND 进行修饰
PR	结束时间点缺失	Consistency	56	手术史和肿瘤诊断无需结束时间 修饰
RS	未能找到 SDTM 规定的期望变量 VISITNUM	Metadata	1	无需 VISITNUM 修饰
RS	所有记录中都缺 失相关允许变量	Presence	2	均存在结果无需 PPSTAT、 PPREASND 进行修饰
SS	SSDTC 日期在 RFPENDTC 后	Limit	4	SSDTC 是访视日期，访视对象是 本人或家人，SSDTC 可以晚于死 亡日期
TR	未能找到 SDTM 规定的期望变量 VISITNUM	Metadata	1	无需 VISITNUM 修饰
TR	同一测试中有多 个基线记录	Consistency	20	通过部位和部位具体位置来进一 步确定唯一测试
TR	模型许可变量被 添加到了标准域 中	Metadata	1	TRBLFL 为基线标识
TS	所有记录中都缺 失相关允许变量	Presence	1	无参数空值
TU	未能找到 SDTM 规定的期望变量 VISITNUM	Metadata	1	无需 VISITNUM 修饰
TU	同一测试中有多 个基线记录	Consistency	13	通过部位和部位具体位置来进一 步确定唯一测试
TU	模型许可变量被 添加到了标准域 中	Metadata	1	TUBLFL 为基线标识

4.3 补充的一致性明细

没有额外的一致性明细需要补充。

附录 I:入选/排除标准

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
1.0	入选标准	INCL01	年龄≥18 岁且≤75 岁（含临界值）；
1.0	入选标准	INCL02	标准治疗失败或对标准治疗不耐受或拒绝接受标准治疗的经组织学或细胞学证实的晚期转移性实体瘤患者；
1.0	入选标准	INCL03	根据 RECIST1.1 标准，至少有 1 处可评估靶病灶；
1.0	入选标准	INCL04	ECOG 评分体能状态为 0-2；
1.0	入选标准	INCL05	有适宜的器官以及造血功能，根据以下实验室检查，无严重的器官功能异常：1.血液学：中性粒细胞绝对计数（ANC）≥1.5×10 ⁹ /L，血小板≥100×10 ⁹ /L，白细胞计数≥3×10 ⁹ /L，血红蛋白≥90g/L；2.肾功能：血清肌酐≤1.5 倍正常上限值（ULN）或肌酐清除率≥50mL/min（采用 Cockcroft-Gault 公式肌酐清除率）；3.肝功能：AST 和 ALT≤2.5 倍 ULN，肝转移患者≤5 倍 ULN；血清胆红素（TBIL）≤1.5 倍 ULN；碱性磷酸酶≤1.5 倍 ULN，肝转移或骨转移患者≤5 倍 ULN；4.凝血功能：国际标准化率（INR）或活化部分凝血活酶时间（APTT）≤1.5 倍 ULN。
1.0	入选标准	INCL06	CD4+T 淋巴细胞计数>350 个/μL；
1.0	入选标准	INCL07	预期生存期≥3 个月；
1.0	入选标准	INCL08	筛选前 2 周内至试验结束后 3 个月内无生育计划且同意在试验期间采取有效的非药物避孕措施；
1.0	入选标准	INCL09	自愿参加试验并签署知情同意书。
1.0	排除标准	EXCL01	对试验药物或辅料过敏者；
1.0	排除标准	EXCL02	未经有效控制的活动性脑转移或有脑膜转移的受试者：筛选前 1 个月需要采用任何放射、手术或药物治疗（包括类固醇、抗惊厥药物等）以控制转移症状者不可入组，存在稳定状态的脑转移者可入组；
1.0	排除标准	EXCL03	既往患有自身免疫性疾病，需使用糖皮质激素或免疫抑制药物者；
1.0	排除标准	EXCL04	未经控制的合并症或癌性疼痛；
1.0	排除标准	EXCL05	经药物治疗后仍无法控制的高血压（收缩压>170 mmHg 或舒张压>100 mmHg）；
1.0	排除标准	EXCL06	既往存在严重心脏疾病病史者，如：12 个月内的急性心肌梗

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			死病史或冠脉成形术或支架植入术、不稳定型心绞痛、心肌炎、≥III 级的慢性心力衰竭（美国纽约心脏病协会标准），或心电图提示有 QT 间期延长（女性>470 ms；男性>450 ms）或严重的心律失常病史者；
1.0	排除标准	EXCL07	既往存在严重肾脏疾病病史者，如慢性肾炎、肾功能不全等；
1.0	排除标准	EXCL08	目前存在未控制的活动性感染；
1.0	排除标准	EXCL09	筛选时有活动性乙型肝炎（HBsAg 阳性，且外周血 HBV DNA 滴度检测 $\geq 1 \times 10^3$ IU/mL）、丙型肝炎、梅毒特异性抗体及人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体筛查结果为阳性患者；
1.0	排除标准	EXCL10	筛选前 5 年内发生其他恶性肿瘤，之前曾以根治为目的进行治疗的子宫原位癌、皮肤鳞状细胞癌或基底细胞癌除外；
1.0	排除标准	EXCL11	筛选前 28 天内接种过新冠疫苗或筛选前 3 个月内接种过其他疫苗或计划在试验期间接种疫苗者；
1.0	排除标准	EXCL12	首次给药前 14 天内接受系统性类固醇治疗且经研究者判定治疗期间需要长期使用系统性类固醇治疗的受试者（吸入性或局部使用、生理替代剂量除外）；
1.0	排除标准	EXCL13	首次给药前 28 天内参加过任何其他干预性临床试验；
1.0	排除标准	EXCL14	首次给药前 28 天内接受过输血和/或集落刺激因子相关治疗；
1.0	排除标准	EXCL15	首次给药前 28 天内接受过重大外科和/或抗肿瘤治疗（包括但不限于化疗、放疗、靶向及免疫治疗等），且未能从这些干预措施的毒性中恢复者（根据 NCI-CTC AE 5.0 版毒性未恢复到 ≤ 1 级），脱发除外；
1.0	排除标准	EXCL16	备孕期、妊娠期、哺乳期女性；
1.0	排除标准	EXCL17	研究者认为可能增加受试者风险或干扰试验结果的其他任何情况，认为不适宜进入本项试验者。
2.0	入选标准	INCL01	年龄 ≥ 18 岁且 ≤ 75 岁（含临界值）；
2.0	入选标准	INCL02	标准治疗失败或对标准治疗不耐受或拒绝接受标准治疗的经组织学或细胞学证实的晚期转移性实体瘤患者（标准治疗失败/不耐受定义：以 NCCN 发布的恶性肿瘤临床实践指南中对末线治疗方案治疗失败或不耐受）；
2.0	入选标准	INCL03	根据 RECIST 1.1 标准，至少有 1 处可评估靶病灶；
2.0	入选标准	INCL04	ECOG 评分体能状态为 0-2；

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
2.0	入选标准	INCL05	有适宜的器官以及造血功能, 根据以下实验室检查, 无严重的器官功能异常: 1.血液学: 中性粒细胞绝对计数 (ANC) $\geq 1.5 \times 10^9/L$, 血小板 $\geq 100 \times 10^9/L$, 白细胞计数 $\geq 3 \times 10^9/L$, 血红蛋白 $\geq 90 \text{ g/L}$; 2.肾功能: 血清肌酐 ≤ 1.5 倍正常上限值 (ULN) 或肌酐清除率 $\geq 50 \text{ mL/min}$ (采用 Cockcroft-Gault 公式肌酐清除率); 3.肝功能: AST 和 ALT ≤ 2.5 倍 ULN, 肝转移患者 ≤ 5 倍 ULN; 血清胆红素 (TBIL) ≤ 1.5 倍 ULN; 碱性磷酸酶 ≤ 1.5 倍 ULN, 肝转移或骨转移患者 ≤ 5 倍 ULN; 4.凝血功能: 国际标准化率 (INR) 或活化部分凝血活酶时间 (APTT) ≤ 1.5 倍 ULN。
2.0	入选标准	INCL06	CD4+T 淋巴细胞计数 > 350 个/ μL ;
2.0	入选标准	INCL07	预期生存期 ≥ 3 个月;
2.0	入选标准	INCL08	筛选前 2 周内至试验结束后 3 个月内无生育计划且同意在试验期间采取有效的非药物避孕措施;
2.0	入选标准	INCL09	自愿参加试验并签署知情同意书。
2.0	排除标准	EXCL01	对试验药物或辅料过敏者;
2.0	排除标准	EXCL02	未经有效控制的活动性脑转移或有脑膜转移的受试者: 筛选前 1 个月需要采用任何放射、手术或药物治疗 (包括类固醇、抗惊厥药物等) 以控制转移症状者不可入组, 存在稳定状态的脑转移者可入组;
2.0	排除标准	EXCL03	既往患有自身免疫性疾病, 需使用糖皮质激素或免疫抑制药物者;
2.0	排除标准	EXCL04	未经控制的合并症或癌性疼痛;
2.0	排除标准	EXCL05	经药物治疗后仍无法控制的高血压 (收缩压 $> 170 \text{ mmHg}$ 或舒张压 $> 100 \text{ mmHg}$);
2.0	排除标准	EXCL06	既往存在严重心脏疾病病史者, 如: 12 个月内的急性心肌梗死病史或冠脉成形术或支架植入术、不稳定型心绞痛、心肌炎、 $\geq \text{III}$ 级的慢性心力衰竭 (美国纽约心脏病协会标准), 或心电图提示有 QT 间期延长 (女性 $> 470 \text{ ms}$; 男性 $> 450 \text{ ms}$) 或严重的心律失常病史者;
2.0	排除标准	EXCL07	既往存在严重肾脏疾病病史者, 如慢性肾炎、肾功能不全等;
2.0	排除标准	EXCL08	目前存在未控制的活动性感染;
2.0	排除标准	EXCL09	筛选时有活动性乙型肝炎 (HBsAg 阳性, 且外周血 HBV

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			DNA 滴度检测 $\geq 1 \times 10^3$ IU/mL)、丙型肝炎、梅毒特异性抗体及人类免疫缺陷病毒 (HIV) 抗体筛查结果为阳性患者;
2.0	排除标准	EXCL10	筛选前 5 年内发生其他恶性肿瘤, 之前曾以根治为目的进行治疗的子宫颈原位癌、皮肤鳞状细胞癌或基底细胞癌除外;
2.0	排除标准	EXCL11	筛选前 28 天内接种过新冠疫苗或筛选前 3 个月内接种过其他疫苗或计划在试验期间接种疫苗者;
2.0	排除标准	EXCL12	首次给药前 14 天内接受系统性类固醇治疗且经研究者判定治疗期间需要长期使用系统性类固醇治疗的受试者 (吸入性或局部使用、生理替代剂量除外);
2.0	排除标准	EXCL13	首次给药前 28 天内参加过任何其他干预性临床试验;
2.0	排除标准	EXCL14	首次给药前 28 天内接受过输血和/或集落刺激因子相关治疗;
2.0	排除标准	EXCL15	首次给药前 28 天内接受过重大外科和/或抗肿瘤治疗 (包括但不限于化疗、放疗、靶向及免疫治疗等), 且未能从这些干预措施的毒性中恢复者 (根据 NCI-CTC AE 5.0 版毒性未恢复到 ≤ 1 级), 脱发除外;
2.0	排除标准	EXCL16	备孕期、妊娠期、哺乳期女性;
2.0	排除标准	EXCL17	研究者认为可能增加受试者风险或干扰试验结果的其他任何情况, 认为不适宜进入本项试验者。
2.1	入选标准	INCL01	年龄 ≥ 18 岁且 ≤ 75 岁 (含临界值);
2.1	入选标准	INCL02	标准治疗失败或对标准治疗不耐受或拒绝接受标准治疗的经组织学或细胞学证实的晚期转移性实体瘤患者 (标准治疗失败/不耐受定义: 以 NCCN 发布的恶性肿瘤临床实践指南中对末线治疗方案治疗失败或不耐受);
2.1	入选标准	INCL03	根据 RECIST 1.1 标准, 至少有 1 处可评估靶病灶;
2.1	入选标准	INCL04	ECOG 评分体能状态为 0-2;
2.1	入选标准	INCL05	有适宜的器官以及造血功能, 根据以下实验室检查, 无严重的器官功能异常: 1.血液学: 中性粒细胞绝对计数 (ANC) $\geq 1.5 \times 10^9/L$, 血小板 $\geq 100 \times 10^9/L$, 白细胞计数 $\geq 3 \times 10^9/L$, 血红蛋白 ≥ 90 g/L; 2.肾功能: 血清肌酐 ≤ 1.5 倍正常上限值 (ULN) 或肌酐清除率 ≥ 50 mL/min (采用 Cockcroft-Gault 公式肌酐清除率); 3.肝功能: AST 和 ALT ≤ 3 倍 ULN, 血清胆红素 (TBIL) ≤ 1.5 倍 ULN; 碱性磷酸酶 ≤ 3 倍 ULN; 对于存在

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			肝转移或为肝癌患者：AST、ALT、血清胆红素≤5 倍 ULN；对于存在肝转移、骨转移或为肝癌、胰腺癌患者：碱性磷酸酶≤5 倍 ULN；4.凝血功能：国际标准化率（INR）或活化部分凝血活酶时间（APTT）≤1.5 倍 ULN。
2.1	入选标准	INCL06	CD4+T 淋巴细胞计数>350 个/ μ L；
2.1	入选标准	INCL07	预期生存期≥3 个月；
2.1	入选标准	INCL08	筛选前 2 周内至试验结束后 3 个月内无生育计划且同意在试验期间采取有效的非药物避孕措施；
2.1	入选标准	INCL09	自愿参加试验并签署知情同意书。
2.1	排除标准	EXCL01	受试者符合以下任何一项标准将不得进入本试验：
2.1	排除标准	EXCL02	对试验药物或辅料过敏者；
2.1	排除标准	EXCL03	未经有效控制的活动性脑转移或有脑膜转移的受试者：筛选前 1 个月需要采用任何放射、手术或药物治疗（包括类固醇、抗惊厥药物等）以控制转移症状者不可入组，存在稳定状态的脑转移者可入组；
2.1	排除标准	EXCL04	既往患有自身免疫性疾病，需使用糖皮质激素或免疫抑制药物者；
2.1	排除标准	EXCL05	未经控制的合并症或癌性疼痛；
2.1	排除标准	EXCL06	经药物治疗后仍无法控制的高血压（收缩压>170 mmHg 或舒张压>100 mmHg）；
2.1	排除标准	EXCL07	既往存在严重心脏疾病病史者，如：12 个月内的急性心肌梗死病史或冠脉成形术或支架植入术、不稳定型心绞痛、心肌炎、≥III 级的慢性心力衰竭（美国纽约心脏病协会标准），或心电图提示有 QT 间期延长（女性>470 ms；男性>450 ms）或严重的心律失常病史者；
2.1	排除标准	EXCL08	既往存在严重肾脏疾病病史者，如慢性肾炎、肾功能不全等；
2.1	排除标准	EXCL09	目前存在未控制的活动性感染；
2.1	排除标准	EXCL10	筛选时有活动性乙型肝炎（HBsAg 阳性，且外周血 HBV DNA 滴度检测≥ 1×10^3 IU/mL）、丙型肝炎、梅毒特异性抗体及人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体筛查结果为阳性患者；
2.1	排除标准	EXCL11	筛选前 5 年内发生其他恶性肿瘤，之前曾以根治为目的进行治疗的子宫原位癌、皮肤鳞状细胞癌或基底细胞癌除外；
2.1	排除标准	EXCL12	筛选前 28 天内接种过新冠疫苗或筛选前 3 个月内接种过其

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			他疫苗或计划在试验期间接种疫苗者;
2.1	排除标准	EXCL13	首次给药前 14 天内接受系统性类固醇治疗且经研究者判定治疗期间需要长期使用系统性类固醇治疗的受试者(吸入性或局部使用、生理替代剂量除外);
2.1	排除标准	EXCL14	首次给药前 28 天内参加过任何其他干预性临床试验;
2.1	排除标准	EXCL15	首次给药前 14 天内接受过输血和/或集落刺激因子相关治疗;
2.1	排除标准	EXCL16	首次给药前 28 天内接受过重大外科和/或抗肿瘤治疗(包括但不限于化疗、放疗、靶向及免疫治疗等),且未能从这些干预措施的毒性中恢复者(根据 NCI-CTC AE 5.0 版毒性未恢复到≤1 级),脱发除外;
2.1	排除标准	EXCL17	备孕期、妊娠期、哺乳期女性;
2.2	入选标准	INCL01	年龄≥18 岁且≤75 岁(含临界值);
2.2	入选标准	INCL02	标准治疗失败或对标准治疗不耐受或拒绝接受标准治疗的经组织学或细胞学证实的晚期转移性实体瘤患者(标准治疗失败/不耐受定义:以 NCCN 发布的恶性肿瘤临床实践指南中对末线治疗方案治疗失败或不耐受);
2.2	入选标准	INCL03	根据 RECIST 1.1 标准,至少有 1 处可评估靶病灶;
2.2	入选标准	INCL04	ECOG 评分体能状态为 0-2;
2.2	入选标准	INCL05	有适宜的器官以及造血功能,根据以下实验室检查,无严重的器官功能异常:1.血液学:中性粒细胞绝对计数(ANC)≥ $1.5 \times 10^9/L$,血小板≥ $100 \times 10^9/L$,白细胞计数≥ $3 \times 10^9/L$,血红蛋白≥90 g/L;2.肾功能:血清肌酐≤1.5 倍正常上限值(ULN)或肌酐清除率≥50 mL/min(采用 Cockcroft-Gault 公式肌酐清率);3.肝功能:AST 和 ALT≤3 倍 ULN,血清胆红素(TBIL)≤1.5 倍 ULN;碱性磷酸酶≤3 倍 ULN;对于存在肝转移或为肝癌患者:AST、ALT、血清胆红素≤5 倍 ULN;对于存在肝转移、骨转移或为肝癌、胰腺癌患者:碱性磷酸酶≤5 倍 ULN;4.凝血功能:国际标准化率(INR)或活化部分凝血活酶时间(APTT)≤1.5 倍 ULN。
2.2	入选标准	INCL06	CD4+T 淋巴细胞计数>350 个/ μL ;
2.2	入选标准	INCL07	预期生存期≥3 个月;
2.2	入选标准	INCL08	筛选前 2 周内至试验结束后 3 个月内无生育计划且同意在

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			试验期间采取有效的非药物避孕措施;
2.2	入选标准	INCL09	自愿参加试验并签署知情同意书。
2.2	排除标准	EXCL01	对试验药物或辅料过敏者;
2.2	排除标准	EXCL02	未经有效控制的活动性脑转移或有脑膜转移的受试者: 筛选前 1 个月需要采用任何放射、手术或药物治疗(包括类固醇、抗惊厥药物等)以控制转移症状者不可入组, 存在稳定状态的脑转移者可入组;
2.2	排除标准	EXCL03	既往患有自身免疫性疾病, 需使用糖皮质激素或免疫抑制药物者;
2.2	排除标准	EXCL04	未经控制的合并症或癌性疼痛;
2.2	排除标准	EXCL05	经药物治疗后仍无法控制的高血压(收缩压>170 mmHg 或舒张压>100 mmHg);
2.2	排除标准	EXCL06	既往存在严重心脏疾病病史者, 如: 12 个月内的急性心肌梗死病史或冠脉成形术或支架植入术、不稳定型心绞痛、心肌炎、≥III 级的慢性心力衰竭(美国纽约心脏病协会标准), 或心电图提示有 QT 间期延长(女性>470 ms; 男性>450 ms)或严重的心律失常病史者;
2.2	排除标准	EXCL07	既往存在严重肾脏疾病病史者, 如慢性肾炎、肾功能不全等;
2.2	排除标准	EXCL08	目前存在未控制的活动性感染;
2.2	排除标准	EXCL09	筛选时有活动性乙型肝炎(HBsAg 阳性, 且外周血 HBV DNA 滴度检测 $\geq 1 \times 10^3$ IU/mL)、丙型肝炎、梅毒特异性抗体及人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体筛查结果为阳性患者;
2.2	排除标准	EXCL10	筛选前 5 年内发生其他恶性肿瘤, 之前曾以根治为目的进行治疗的子宫原位癌、皮肤鳞状细胞癌或基底细胞癌除外;
2.2	排除标准	EXCL11	筛选前 28 天内接种过新冠疫苗或筛选前 3 个月内接种过其他疫苗或计划在试验期间接种疫苗者;
2.2	排除标准	EXCL12	首次给药前 14 天内接受系统性类固醇治疗且经研究者判定治疗期间需要长期使用系统性类固醇治疗的受试者(吸入性或局部使用、生理替代剂量除外);
2.2	排除标准	EXCL13	首次给药前 28 天内参加过任何其他干预性临床试验;
2.2	排除标准	EXCL14	首次给药前 14 天内接受过输血和/或集落刺激因子相关治疗;
2.2	排除标准	EXCL15	首次给药前 28 天内或 5 个半衰期内(以较短者为准)接受过

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			重大外科和/或抗肿瘤治疗(包括但不限于化疗、放疗、靶向及免疫治疗等), 且未能从这些干预措施的毒性中恢复者(根据 T5.0 版毒性未恢复到≤1 级), 脱发除外;
2.2	排除标准	EXCL16	备孕期、妊娠期、哺乳期女性;
2.2	排除标准	EXCL17	研究者认为可能增加受试者风险或干扰试验结果的其他任何情况, 认为不适宜进入本项试验者。
2.3	入选标准	INCL01	年龄≥18 岁且≤75 岁 (含临界值);
2.3	入选标准	INCL02	标准治疗失败或对标准治疗不耐受或拒绝接受标准治疗的经组织学或细胞学证实的晚期转移性实体瘤患者(标准治疗失败/不耐受定义: 以 NCCN 发布的恶性肿瘤临床实践指南中对末线治疗方案治疗失败或不耐受);
2.3	入选标准	INCL03	根据 RECIST 1.1 标准, 至少有 1 处可评估靶病灶;
2.3	入选标准	INCL04	ECOG 评分体能状态为 0-2;
2.3	入选标准	INCL05	有适宜的器官以及造血功能, 根据以下实验室检查, 无严重的器官功能异常: 1.血液学: 中性粒细胞绝对计数 (ANC) ≥1.5×10 ⁹ /L, 血小板≥100×10 ⁹ /L, 白细胞计数≥3×10 ⁹ /L, 血红蛋白≥90 g/L; 2.肾功能: 血清肌酐≤1.5 倍正常上限值 (ULN) 或肌酐清除率≥50 mL/min (采用 Cockcroft-Gault 公式肌酐清除率); 3.肝功能: AST 和 ALT≤3 倍 ULN, 血清胆红素 (TBIL) ≤1.5 倍 ULN; 碱性磷酸酶≤3 倍 ULN; 对于存在肝转移或为肝癌患者: AST、ALT、血清胆红素≤5 倍 ULN; 对于存在肝转移、骨转移或为肝癌、胰腺癌患者: 碱性磷酸酶≤5 倍 ULN; 4.凝血功能: 国际标准化率 (INR) 或活化部分凝血活酶时间 (APTT) ≤1.5 倍 ULN。
2.3	入选标准	INCL06	CD4+T 淋巴细胞计数>350 个/μL;
2.3	入选标准	INCL07	预期生存期≥3 个月;
2.3	入选标准	INCL08	筛选前 2 周内至试验结束后 3 个月内无生育计划且同意在试验期间采取有效的非药物避孕措施;
2.3	入选标准	INCL09	自愿参加试验并签署知情同意书。
2.3	排除标准	EXCL01	对试验药物或辅料过敏者;
2.3	排除标准	EXCL02	未经有效控制的活动性脑转移或有脑膜转移的受试者: 筛选前 1 个月需要采用任何放射、手术或药物治疗(包括类固醇、抗惊厥药物等)以控制转移症状者不可入组, 存在稳定状态

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			的脑转移者可入组;
2.3	排除标准	EXCL03	既往患有自身免疫性疾病,需使用糖皮质激素或免疫抑制药物者;
2.3	排除标准	EXCL04	未经控制的合并症或癌性疼痛;
2.3	排除标准	EXCL05	经药物治疗后仍无法控制的高血压(收缩压 >170 mmHg 或舒张压 >100 mmHg);
2.3	排除标准	EXCL06	既往存在严重心脏疾病病史者,如:12个月内的急性心肌梗死病史或冠脉成形术或支架植入术、不稳定型心绞痛、心肌炎、 $\geq$ III级的慢性心力衰竭(美国纽约心脏病协会标准),或心电图提示有QT间期延长(女性 >470 ms; 男性 >450 ms)或严重的心律失常病史者;
2.3	排除标准	EXCL07	既往存在严重肾脏疾病病史者,如慢性肾炎、肾功能不全等;
2.3	排除标准	EXCL08	目前存在未控制的活动性感染;
2.3	排除标准	EXCL09	筛选时有活动性乙型肝炎(HBsAg 阳性,且外周血 HBV DNA 滴度检测 $\geq 1 \times 10^3$ IU/mL)、丙型肝炎、梅毒特异性抗体及人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体筛查结果为阳性患者;
2.3	排除标准	EXCL10	筛选前5年内发生其他恶性肿瘤,之前曾以根治为目的进行治疗的子宫原位癌、皮肤鳞状细胞癌或基底细胞癌除外;
2.3	排除标准	EXCL11	筛选前28天内接种过新冠疫苗或筛选前3个月内接种过其他疫苗或计划在试验期间接种疫苗者;
2.3	排除标准	EXCL12	首次给药前14天内接受系统性类固醇治疗且经研究者判定治疗期间需要长期使用系统性类固醇治疗的受试者(吸入性或局部使用、生理替代剂量除外);
2.3	排除标准	EXCL13	同时入组另一项临床研究,除非该研究是一项观察性(非干预性)临床研究或处于一项干预性研究的随访期;
2.3	排除标准	EXCL14	首次给药前14天内接受过输血和/或集落刺激因子相关治疗;
2.3	排除标准	EXCL15	首次给药前28天内或5个半衰期内(以较短者为准)接受过重大外科和/或抗肿瘤治疗(包括但不限于化疗、放疗、靶向及免疫治疗等),且未能从这些干预措施的毒性中恢复者(根据NCI-CTCAE 5.0版毒性未恢复到 ≤ 1 级),脱发除外;
2.3	排除标准	EXCL16	备孕期、妊娠期、哺乳期女性;
2.3	排除标准	EXCL17	研究者认为可能增加受试者风险或干扰试验结果的其他任

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			何情况, 认为不适宜进入本项试验者。
3.0	入选标准	INCL01	年龄 ≥ 18 岁且 ≤ 75 岁(含临界值);
3.0	入选标准	INCL02	标准治疗失败或对标准治疗不耐受或拒绝接受标准治疗的经组织学或细胞学证实的晚期转移性实体瘤患者(标准治疗失败/不耐受定义: 以 NCCN 发布的恶性肿瘤临床实践指南中对末线治疗方案治疗失败或不耐受);
3.0	入选标准	INCL03	根据 RECIST 1.1 标准, 至少有 1 处可评估靶病灶;
3.0	入选标准	INCL04	ECOG 评分体能状态为 0-2;
3.0	入选标准	INCL05	有适宜的器官以及造血功能, 根据以下实验室检查, 无严重的器官功能异常: 1.血液学: 中性粒细胞绝对计数(ANC) $\geq 1.5 \times 10^9/L$, 血小板 $\geq 100 \times 10^9/L$, 白细胞计数 $\geq 3 \times 10^9/L$, 血红蛋白 ≥ 90 g/L; 2.肾功能: 血清肌酐 ≤ 1.5 倍正常上限值(ULN)或肌酐清除率 ≥ 50 mL/min(采用 Cockcroft-Gault 公式肌酐清率); 3.肝功能: AST 和 ALT ≤ 3 倍 ULN, 血清胆红素(TBIL) ≤ 1.5 倍 ULN; 碱性磷酸酶 ≤ 3 倍 ULN; 对于存在肝转移或为肝癌患者: AST、ALT、血清胆红素 ≤ 5 倍 ULN; 对于存在肝转移、骨转移或为肝癌、胰腺癌患者: 碱性磷酸酶 ≤ 5 倍 ULN; 4.凝血功能: 国际标准化率(INR)或活化部分凝血活酶时间(APTT) ≤ 1.5 倍 ULN。
3.0	入选标准	INCL06	CD4+T 淋巴细胞计数 > 350 个/ μL ;
3.0	入选标准	INCL07	预期生存期 ≥ 3 个月;
3.0	入选标准	INCL08	筛选前 2 周内至试验结束后 3 个月内无生育计划且同意在试验期间采取有效的非药物避孕措施;
3.0	入选标准	INCL09	自愿参加试验并签署知情同意书。
3.0	排除标准	EXCL01	对试验药物或辅料过敏者;
3.0	排除标准	EXCL02	未经有效控制的活动性脑转移或有脑膜转移的受试者: 筛选前 1 个月需要采用任何放射、手术或药物治疗(包括类固醇、抗惊厥药物等)以控制转移症状者不可入组, 存在稳定状态的脑转移者可入组;
3.0	排除标准	EXCL03	既往患有自身免疫性疾病, 需使用糖皮质激素或免疫抑制药物者;
3.0	排除标准	EXCL04	未经控制的合并症或癌性疼痛;
3.0	排除标准	EXCL05	经药物治疗后仍无法控制的高血压(收缩压 > 170 mmHg 或

方案版本	分类	IETEST CD	入选/排除标准的完整描述
			舒张压>100 mmHg);
3.0	排除标准	EXCL06	既往存在严重心脏疾病病史者,如:12个月内的急性心肌梗死病史或冠脉成形术或支架植入术、不稳定型心绞痛、心肌炎、≥III级的慢性心力衰竭(美国纽约心脏病协会标准),或心电图提示有QT间期延长(女性>470 ms;男性>450 ms)或严重的心律失常病史者;
3.0	排除标准	EXCL07	既往存在严重肾脏疾病病史者,如慢性肾炎、肾功能不全等;
3.0	排除标准	EXCL08	目前存在未控制的活动性感染;
3.0	排除标准	EXCL09	筛选时有活动性乙型肝炎(HBsAg阳性,且外周血HBV DNA滴度检测 $\geq 1 \times 10^3$ IU/mL)、丙型肝炎、梅毒特异性抗体及人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体筛查结果为阳性患者;
3.0	排除标准	EXCL10	筛选前5年内发生其他恶性肿瘤,之前曾以根治为目的进行治疗的宫颈原位癌、皮肤鳞状细胞癌或基底细胞癌除外;
3.0	排除标准	EXCL11	筛选前28天内接种过新冠疫苗或筛选前3个月内接种过其他疫苗或计划在试验期间接种疫苗者;
3.0	排除标准	EXCL12	首次给药前14天内接受系统性类固醇治疗且经研究者判定治疗期间需要长期使用系统性类固醇治疗的受试者(吸入性或局部使用、生理替代剂量除外);
3.0	排除标准	EXCL13	同时入组另一项临床研究,除非该研究是一项观察性(非干预性)临床研究或处于一项干预性研究的随访期;
3.0	排除标准	EXCL14	首次给药前14天内接受过输血和/或集落刺激因子相关治疗;
3.0	排除标准	EXCL15	首次给药前28天内或5个半衰期内(以较短者为准)接受过重大外科和/或抗肿瘤治疗(包括但不限于化疗、放疗、靶向及免疫治疗等),且未能从这些干预措施的毒性中恢复者(根据NCI-CTCAE 5.0版毒性未恢复到 ≤ 1 级),脱发除外;
3.0	排除标准	EXCL16	备孕期、妊娠期、哺乳期女性;
3.0	排除标准	EXCL17	研究者认为可能增加受试者风险或干扰试验结果的其他任何情况,认为不适宜进入本项试验者。